Actualizaciones en cefaleas y migrañas I: generalidades

Dolor visceral y otras entidades clínicas en el ámbito del dolor crónico

tech

CONTENIDO

1. Objetivos

2. Introducción

3. Clasificación internacional de las cefaleas (ICHD- III)

4. Diagnóstico diferencial entre cefaleas primarias y secundarias

5. Principales cefaleas

Cefalea tensional.
Migraña.
Cefalea en racimos.

6. Bibliografía

Objetivos

El objetivo en este extenso tema es aportar al alumno los puntos clave necesarios para diferenciar las principales cefaleas que es posible encontrar en la práctica clínica y así realizar un tratamiento efectivo.

Introducción

Se denomina cefalea al dolor o sensación desagradable en la cabeza: región de la bóveda craneal, desde la región occipital, incluyendo también la zona cervical y facial. La cefalea es un síntoma tan frecuente que afecta al 91 % de los hombres y 99 % de las mujeres, por lo menos una vez en la vida. Es motivo del 4 % de las consultas médicas.

Generalmente es un trastorno benigno y transitorio que cede espontáneamente o con la ayuda de algún analgésico. También puede ser el síntoma de una enfermedad grave que es necesario identificar.

Hay que distinguirlo de las neuralgias craneofaciales que corresponderían al dolor localizado únicamente en el trayecto de un nervio y que son mayoritariamente faciales.

Se suelen distinguir dos tipos de cefaleas. Las cefaleas primarias, que son las más frecuentes y en las que no se conoce con exactitud su causa, incluyen las migrañas, la cefalea tensional, la cefalea en racimos y otras. Las cefaleas secundarias constituirían un síntoma de otras enfermedades, como procesos expansivos intracraneales, lesiones de estructuras pericraneales, traumatismos, etc.

Clasificación internacional de las cefaleas (ICHD- III)

La IHS publico la última actualización de la tercera edición de la Clasificación Internacional de las Cefaleas (ICHD-III) en 2018. Es la guía diagnóstica de las cefaleas más utilizada en el mundo. Revisa y explica las nuevas entidades que aparecen, comparándolas con la sedición precedente.

Diagnóstico diferencial entre cefaleas primarias y secundarias

La anamnesis es el instrumento principal en el diagnóstico de las cefaleas primarias y muchos errores vienen condicionados por una anamnesis deficiente.

Es importante precisar el tiempo de evolución y la periodicidad de la cefalea. Como regla general, las cefaleas de más de 3 meses de evolución raramente serán secundarias a un proceso invasivo intracraneal. Las cefaleas agudas e intensas en pacientes sin antecedentes de cefalea obligan a descartar enfermedades graves, como una hemorragia subaracnoidea o cerebral.

La edad de comienzo también es importante. Las cefaleas de inicio antes de los 30 años casi siempre corresponden a una cefalea primaria. Las cefaleas que comienzan después de los 65 años obligan a descartar una cefalea secundaria, como un proceso invasivo intracraneal o una arteritis de la temporal.

Deben valorarse las características del dolor. La cefalea tensional es típicamente continua, suele aumentar por la tarde y sólo cede con el sueño. El dolor de un proceso expansivo es continuo y predomina por la mañana al levantarse, la arteritis de la temporal o la cefalea en acúmulos suelen predominar por la noche. Se acepta que la migraña dura de 4 a 72 horas, mientras que los episodios de cefalea en racimos o acúmulos suelen durar típicamente de 30 a 120 minutos.

En cuanto a la localización, la migraña suele ser típicamente hemicránea aunque en no todos los casos, la cefalea tensional suele ser de localización holocránea de predominio en vertex y en región posterior del cráneo, la cefalea en racimos es periocular y la arteritis se ubica en la región temporal.

En cuanto a la intensidad, los pacientes con migraña la suelen describir como moderada–severa y con características pulsátiles, mientras que en la cefalea tensional la suelen describir como más leve y de carácter gravitativo.

Los síntomas acompañantes pueden dar indicios sobre el tipo de cefalea del que se trata.

El aura, la fotofobia, fonofobia y las náuseas o vómitos son típicos de la migraña. En la cefalea en acúmulos suele aparecer lagrimeo, rinorrea y signo de Horner. En la arteritis de la temporal puede asociarse una claudicación mandibular y la cefalea tumoral puede acompañarse de otros síntomas o signos neurológicos.

Los factores que provocan o alivian el dolor también pueden ser útiles. Por ejemplo, la migraña típicamente se intensifica con movimientos bruscos, la cefalea tensional puede ceder apoyando la cabeza y en la malformación de Arnold-Chiari el dolor puede desencadenarse por la tos.

También se debe interrogar al paciente sobre la eficacia y tolerabilidad de los fármacos ensayados, así como si se han usado de forma apropiada.

Es importante la realización de una exploración neurológica completa con examen de fondo de ojo que en caso de detectar alteraciones dará indicios de una cefalea secundaria.

En la mayoría de las cefaleas se puede hacer el diagnóstico con la anamnesis y la exploración neurológica.

Si es una cefalea que comienza después de los 65 años habría que solicitar una velocidad de sedimentación y, en caso de sospecha de infección, una analítica de sangre y, en algún caso, análisis de líquido cefalorraquídeo.

El TAC y la RM cerebral debe solicitarse: si se desencadena por el esfuerzo, es de inicio súbito, se acompaña de focalidad, no responde al tratamiento, reciente aparición en ancianos con VSG normal.

Principales cefaleas

Las cefaleas son un grupo muy amplio y heterogéneo de entidades clínicas, y representan un importante problema de salud. En torno a ellas se ha suscitado un notable interés en los últimos años y, en consecuencia, se han alcanzado considerables avances científicos.

Una de las herramientas que, sin lugar a duda, ha contribuido más a este progreso ha sido la Clasificación Internacional de las Cefaleas, así como el elevado número de ensayos clínicos que se han llevado a cabo con fármacos para el tratamiento agudo y preventivo.

También ha contribuido a este progreso la introducción de nuevas escalas de medidas de calidad de vida, de productividad, medidas de eficacia y de discapacidad. Todo esto ha permitido comparar mejor los nuevos fármacos entre sí y con los anteriores, lo que ha favorecido de manera decisiva el desarrollo de las diferentes áreas de las cefaleas, siendo la migraña, sin duda alguna, la entidad clínica que más se ha beneficiado de este avance científico.

Dada la extensión del tema se presentarán tres tipos de cefaleas primarias. Estas han sido seleccionadas en función de su prevalencia, intensidad o refractariedad, ya que podrían ser objeto de estimación diagnóstica o terapéutica en la Unidad del dolor:

- Cefalea tensional.
- Migraña.
- Cefalea en racimos.

Cefalea tensional

Es la forma más frecuente de cefalea. Su prevalencia se estima entre el 30 % y el 78 % de la población. La edad de inicio suele ser entre los 20 y los 30 años, aunque puede iniciarse a cualquier edad. La máxima prevalencia es entre los 20 y 30 años y afecta más a las mujeres.

El diagnóstico es clínico y sus manifestaciones más inespecíficas que las de la migraña, por lo que hay autores que, más que una entidad, creen que puede ser un síndrome debido a múltiples causas. En los criterios diagnósticos de la IHS se reconoce como un dolor de localización bilateral, calidad opresiva, no pulsátil, de intensidad leve-moderada, que no se agrava con la actividad física y que no se suele asociar a manifestaciones vegetativas.

Hay autores con una gran experiencia que reconocen que es una de las cefaleas de más difícil diagnóstico, siendo un reto tanto para los novatos como para los expertos. Sería una cefalea vaga, con escasos síntomas, leve o moderada, no pulsátil, bilateral, sobre todo femenina e idiopática, la cual es difícil de clasificar y más o menos no remediable. Los criterios serían como los contrarios a la migraña. Su nombre tensional hace referencia a una cierta tensión muscular o emocional.

La duración de la cefalea es variable. El diagnóstico viene reforzado si la cefalea es de larga evolución (más de 3 meses), si se trata de una mujer, a partir de la edad media sin antecedentes de migraña, si coexiste con depresión o ansiedad y si el examen neurológico es normal.

Es indudable que deben existir pacientes con cefalea tensional, de hecho, también tiene un componente hereditario pero muchas veces los límites con otras patologías o comorbilidades son difíciles de establecer.

Migraña

Es una afección crónica, caracterizada por crisis recurrentes de dolor de cabeza moderado o intenso, acompañada ocasionalmente de síntomas neurológicos (como el aura) o manifestaciones sistémicas (como las náuseas o vómitos), que produce un impacto importante en la calidad de vida del que la padece.

La migraña es una enfermedad muy frecuente que afecta entre el 10 % y el 12 % de la población, siendo la prevalencia en mujeres más elevada, duplicando la cifra de los varones. La prevalencia suele ser máxima entre los 25 y 45 años. Según los criterios de Silverstein y Lipton, la migraña crónica se presenta cuando existe cefalea 15 días al mes o más durante al menos 3 meses en pacientes migrañosos, calculándose que entre el 2 % y el 2,5 % de la población, sobre todo mujeres de edad media, cumplen estos criterios. Un tercio de las migrañas crónicas cumplirían criterios de abuso de analgésicos.

También, es importante considerar la comorbilidad que frecuentemente acompaña a la migraña, siendo más frecuente en migrañosos las alteraciones psiquiátricas, depresión y ansiedad, la epilepsia, las enfermedades cardiovasculares, el asma y la alergia.

Manifestaciones clínicas

La migraña es una afección crónica de carácter episódico que se manifiesta por crisis de dolor de cabeza. Entre las crisis el paciente suele estar normal. La frecuencia de las crisis es variable, suele ser de entre una crisis cada dos meses y varias por semana, pero hay pacientes que tiene una crisis al año o menos.

Hasta dos tercios de los pacientes con migraña son capaces de identificar uno o más factores precipitantes o desencadenantes de las crisis migrañosas. Estos factores varían en los distintos pacientes y un mismo factor no siempre desencadena las crisis en el mismo individuo. Los factores más relacionados son: el estrés (también la relajación tras el estrés) y las alteraciones hormonales en la mujer (periodo premenstrual y menstrual). La relación de la dieta con la migraña ha sido muy debatida, pero hasta un 50 % de los pacientes refieren que las bebidas alcohólicas pueden desencadenar las crisis migrañosas, algunos refieren un solo tipo de licor, como el vino tinto. Otros alimentos también han sido involucrados como el chocolate, los cítricos, el plátano, los quesos curados y los alimentos fritos. El ayuno también es un precipitante habitual de las crisis hasta en el 40 % de los adultos. Otros factores involucrados han sido: la alteración del ritmo del sueño, especialmente la privación de sueño, la exposición a ruidos o luces brillantes, los cambios de tiempo y la ingesta de ciertos fármacos, entre ellos los que ms frecuentemente producen migraña son los anovulatorios y vasodilatadores.

Ciertos pacientes tienen síntomas prodrómicos que pueden preceder a la crisis en unas pocas horas o hasta dos días. Los más frecuentes son: ansiedad, fotofobia, irritabilidad, bostezos, tristeza y ansiedad por comidas dulces.

Se puede dividir la migraña según su sintomatología en:

- **La migraña con aura o típica:** afecta a entre el 15 % y el 20 % de los migrañosos. Consiste en la aparición de una sintomatología neurológica focal inmediatamente antes o coincidiendo con la aparición del dolor. En más del 90 % de los casos el aura precede a la cefalea y la mayor parte de las auras son de la esfera visual, son típicos los escotomas en forma de zigzag que se van agrandando progresivamente, a veces son coloreados y dan lugar a lo que se conoce como espectros de fortificación. A veces son bilaterales, pero más de dos tercios de los pacientes los describen en un solo campo visual. Otros síntomas visuales son borrosidad visual, distorsión de objetos, hemianopsia o cuadrantopsia y alucinaciones visuales. Las auras sensitivas también son frecuentes, como parestesias que afectan sobre todo a la mano y la cara, que suelen tener un carácter ascendente. En un 10 % de los pacientes con aura esta se manifiesta como una debilidad motora casi siempre asociada a parestesias. Entre un 10 % y un 20 % de los pacientes con aura presentan una afasia transitoria. En el 90 % de los casos de aura hemicorporal la cefalea es

contralateral al aura. En pacientes migrañosos de edades medias o avanzadas la migraña con aura se va trasformando a un aura aislada, planteando problemas de diagnóstico diferencial con los ACV transitorios.

- **La migraña común o sin aura:** suele ser de predominio femenino y se suele iniciar en la infancia o adolescencia, presentando antecedentes familiares en más del 50 % de los casos. Es la forma más frecuente, presentándose en el 80 % de los casos de migraña. En estos casos la cefalea es el síntoma fundamental. El dolor de las crisis de migraña dura entre 4 y 72 horas, suele ser unilateral en más del 50 % de los pacientes, con localización periocular y en la sien en la mayoría de los pacientes. En un porcentaje reducido de pacientes el dolor puede ser de localización posterior en región occipital. Suele tener predominio unilateral pero es frecuente que también afecte al otro lado. La localización unilateral constante del dolor migrañoso obliga a descartar cefalea sintomática. Es típica la progresión lenta del dolor, desde una molestia hasta un dolor moderado que no interfiere las actividades habituales, y si no se trata en 30 a 120 minutos evoluciona a un dolor severo con interferencia de las actividades habituales. Más de dos tercios de los pacientes refieren el dolor con características pulsátiles. El dolor es agravado por la luz, los ruidos, y sobre todo por movimientos bruscos (signo del traqueteo) o ejercicio.

Cefalea en racimos

La cefalea en racimos pertenece al grupo de las cefaleas trigémino-autonómicas que comparten la localización trigeminal del dolor y la activación de un reflejo trigeminofacial, que da lugar a las manifestaciones vegetativas opculofaciales.

Se caracteriza por la aparición cíclica de periodos sintomáticos, durante los que aparece la cefalea estrictamente unilateral, breve e intensa que se acompaña de, al menos, uno de los siguientes signos vegetativos oculofaciales homolaterales:

- Hiperemia conjuntival.
- Lagrimeo.
- Congestión nasal.
- Rinorrea.
- Sudoración frontal o facial.
- Miosis, ptosis y edema palpebral.

Se caracteriza por ser la única cefalea primaria que predomina en varones y porque en el 5 % de los casos es secundaria a un proceso intracranial, por lo que este tipo de cefaleas deben ser derivadas al nivel especializado.

Los episodios duran entre 15 y 180 minutos y recurren con frecuencia variable entre un ataque cada dos días y ocho ataques diarios.

Se han descrito dos formas de presentación: la episódica y la crónica.

La episódica es más frecuente, entre una crisis y otra la duración es variable, pero en 1 año los episodios tienen que estar separados por al menos 1 mes. En la forma crónica las crisis recurren durante más de 1 año sin periodos de remisión o con remisiones menores a 1 mes.

Bibliografía

1. J.Pascual, A.Oterino, V.Mateos, J.M. Laínez. Migraña y cefalea de tensión. En J. Pascual ed. Tratado de Neurología. Madrid: Luzan; 2012. 107-137 pp.
2. M. L. Cuadrado, V.Mateos, J.A.Pareja. Cefaleas trigeminoautonómicas y otras cefaleas primarias. Cefaleas secundarias. Neuralgias craneofaciales. En J. Pascual ed. Tratado de Neurología. Madrid: Luzan; 2012. 137-193 pp.
3. Lainez JM, Castillo J, Gonzalez VM, Otero M, Mateos V, Leira R, y J.Pascual. Grupo de estudio de cefaleas. Guía de recomendaciones para el tratamiento de la migraña en la práctica clínica. Rev Clin Esp. 2007;207(4):190-193.
4. Saxhaug E, Lundqvist C. Medication-overuse headache: a review. Journal of pain research. 2014:7:367-378.
5. S. Diaz. L mito de la cefalea tensional. Rev Neurol 2014; 58 (suppl 2): S27-S31. E. Cernuda-Morollón, J.Pascual. Algo se mueve en la migraña crónica. Rev Neurol. 2014;58 (1):1-3.
6. R.M.Pluta. Cefalea tensional. JAMA ed. Española. 2011; 36 (4).